

Tái tạo niệu quản là phẫu thuật sửa chữa niệu quản bị tắc hoặc hẹp — ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang — nhằm khôi phục dòng chảy thông thoáng và bảo vệ thận. Phương pháp phụ thuộc vào vị trí và chiều dài chỗ hẹp; có thể nối lại hai đầu niệu quản, dùng mảnh ghép mô, hoặc thay bằng một đoạn ruột.

Về ca phẫu thuật này

Chỗ **hẹp** (sẹo làm thu hẹp lòng niệu quản) cản trở dòng nước tiểu và có thể gây hại cho thận. Phương pháp sửa chữa tùy theo mức độ hẹp:

- **Hẹp ngắn** — cắt bỏ đoạn hẹp rồi nối hai đầu lại (nối trực tiếp), hoặc nối lại niệu quản vào bàng quang (đôi khi bàng quang được kéo lên để đủ tầm).
- **Hẹp dài hơn** — niệu quản được mở rộng bằng **mảnh ghép**, thường lấy từ niêm mạc bên trong má (ghép niêm mạc má — có tờ hướng dẫn riêng).
- **Tổn thương rất dài hoặc nặng** — dùng một đoạn ruột của chính bạn để bắc cầu hoặc thay thế phần niệu quản bị mất.

Một **ống thông JJ (stent)** mềm được đặt bên trong để giữ chỗ sửa chữa thông thoáng trong khi lành. Thủ thuật thường được thực hiện **bằng robot hoặc nội soi** (xâm lấn tối thiểu), đôi khi mổ mở. Tỷ lệ thành công cao.

Có an toàn không?

Đây là các phương pháp sửa chữa đã được thiết lập tốt và hiệu quả, được điều chỉnh theo giải phẫu của từng bệnh nhân. Như mọi phẫu thuật lớn, có một số rủi ro — chảy máu, nhiễm trùng, hoặc rò nước tiểu tạm thời (thường được kiểm soát bằng stent và dẫn lưu). Tái hẹp là không phổ biến. Nếu dùng đoạn ruột, ruột cần vài ngày phục hồi và bạn có thể thấy một ít chất nhầy trong nước tiểu.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Hẹp

Chỗ bị sẹo, thu hẹp làm chậm hoặc tắc dòng nước tiểu.

Ống thông JJ (stent)

Ống mềm đặt bên trong (hình chữ J kép) giữ chỗ sửa chữa thông thoáng khi lành.

Mảnh ghép

Miếng mô của chính bạn, thường từ niêm mạc má, dùng để mở rộng niệu quản.

Đoạn ruột

Một đoạn ngắn ruột của chính bạn dùng để bắc cầu chỗ hẹp dài.

Nối lại niệu quản

Nối lại niệu quản vào bàng quang (tái cấy niệu quản).

Ứ nước thận

Thận bị căng phồng do nước tiểu ứ đọng phía sau chỗ tắc.

Robot / nội soi

Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua vài vết rạch nhỏ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân nên bạn không cảm thấy gì trong khi mổ. Sau đó, có thể đau tại vết mổ, và stent bên trong có thể gây tiểu gấp hoặc cảm giác tức nhẹ ở hông. Nếu dùng đoạn ruột, ruột cần vài ngày để “thức dậy.” Hầu hết bệnh nhân nằm viện 1–3 đêm; thời gian mổ tùy thuộc vào loại sửa chữa.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân** — tuân theo mọi hướng dẫn (nhịn ăn, và thuốc nào cần ngừng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- **Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — phải điều trị nhiễm trùng trước.
- **Không hút thuốc** — làm chậm lành. Nếu có thể dùng đoạn ruột, bạn có thể cần chuẩn bị ruột; nếu có thể dùng mảnh ghép niêm mạc má, hãy chăm sóc răng miệng.
- Dự tính **mang stent khoảng 4–6 tuần** và sắp xếp người đưa về.

Thông báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu** hoặc đang bị nhiễm trùng
- Đã từng phẫu thuật hoặc xạ trị vùng bụng hoặc chậu trước đây

Quá trình phẫu thuật

1. Bạn được gây mê và dùng kháng sinh dự phòng.
2. Bác sĩ phẫu thuật rạch vết nhỏ (nội soi) hoặc mở để tiếp cận đoạn niệu quản hẹp.
3. Niệu quản được sửa chữa — nối hai đầu, vá bằng mảnh ghép, hoặc bắc cầu bằng đoạn ruột — trên một stent.
4. Có thể đặt một ống dẫn lưu nhỏ, sau đó đóng vết mổ.

Sau phẫu thuật

- Thường xuất viện sau **1–3 ngày**.
- **Stent ở trong khoảng 4–6 tuần**, sau đó được rút trong một lần nội soi bàng quang nhanh tại phòng khám.
- Triệu chứng từ stent — tiểu gấp, tức nhẹ ở hông, hoặc nước tiểu hồng — là **bình thường**.
- Nếu dùng đoạn ruột, ăn nhẹ khi ruột phục hồi. **Tránh nâng vật nặng** vài tuần.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Đau hông hoặc bụng dữ dội hoặc ngày càng nặng hơn
- Chảy máu nhiều hoặc không tiểu được
- Nôn ói kéo dài, hoặc không có hơi và không đại tiện được (nếu dùng đoạn ruột)
- Vết mổ ngày càng đỏ, đau, hoặc có dịch chảy ra

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Tái tạo niệu quản mở thông trở lại niệu quản bị tắc để bảo vệ thận. Phương pháp được chọn phù hợp với bạn — nối trực tiếp, ghép niêm mạc má, hoặc đoạn ruột — trên một stent bên trong.
2. Chuẩn bị: tuân theo hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc, điều trị nhiễm trùng trước, không hút thuốc, dự tính mang stent 4–6 tuần, và sắp xếp người đưa về.
3. Stent có thể gây tiểu gấp cho đến khi được rút tại phòng khám. Gọi ngay nếu có sốt, đau dữ dội, chảy máu nhiều, không tiểu được, hoặc không có hoạt động ruột sau mổ.